

Penfigoide Ampollar

1. Introducción y relevancia clínica

El **penfigoide ampollar (PA)** es una **enfermedad autoinmune crónica**, caracterizada por la formación de **ampollas tensas subepidérmicas** sobre piel sana o eritematosa, causada por **autoanticuerpos dirigidos contra la membrana basal epidérmica**.

Es la **enfermedad ampollar autoinmune más frecuente**, especialmente en adultos mayores. Aunque su curso es crónico, el pronóstico es favorable con diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.

Relevancia clínica

- Afecta principalmente a adultos mayores (>60 años).
 - Puede confundirse con urticaria, eczema o dermatitis herpetiforme.
 - El reconocimiento temprano evita complicaciones cutáneas graves (infecciones, deshidratación).
 - En EUNACOM, suele abordarse en preguntas de diagnóstico diferencial con pénfigo vulgar, destacando la **tensión de las ampollas** y la **ausencia de signo de Nikolsky**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo inmunológico

El penfigoide ampollar es una **enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos IgG y complemento** contra antígenos estructurales de la unión dermoepidérmica.

- Los autoanticuerpos se dirigen contra:
 - **BP180 (BPAG2 o colágeno XVII)**
 - **BP230 (BPAG1)**

Ambos componentes de los **hemidesmosomas**, estructuras que anclan la epidermis a la dermis.

- La unión de anticuerpos activa el **complemento (C3)** → reclutamiento de **neutrófilos y eosinófilos** → liberación de proteasas → **separación dermoepidérmica** → formación de ampolla subepidérmica.
-

2.2. Factores desencadenantes

- Edad avanzada (inmunosenescencia).
 - Fármacos: furosemida, espironolactona, penicilamina, AINEs, antibióticos (amoxicilina, vancomicina).
 - Radioterapia o exposición UV.
 - Enfermedades neurológicas asociadas (Parkinson, demencia, esclerosis múltiple).
 - Neoplasias (raro).
-

2.3. Diferencias con pénfigo vulgar

Característica	Penfigoide ampollar	Pénfigo vulgar
Nivel de ampolla	Subepidérmica	Intraepidérmica
Ampolla	Tensa	Flácida
Nikolsky	Negativo	Positivo
Mucosas	Rara vez afectadas	Frecuente
Autoanticuerpos	Anti-BP180 / BP230	Anti-desmogleína 1 y 3

Edad típica	>60 años	40–60 años
Mortalidad	Baja	Alta sin tratamiento

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión elemental

- **Ampolla tensa, serosa o hemática, sobre piel eritematosa o sana.**
 - No se rompe fácilmente.
 - No deja erosiones profundas tras romperse.
-

3.2. Fases clínicas

1. Fase prodrómica (no ampollar):

- Prurito intenso, urticaria persistente, placas eritematosas o eczematosas.
- Puede durar semanas o meses antes de aparecer las ampollas.

2. Fase ampollar:

- Ampollas grandes (>1 cm), tensas, llenas de líquido claro o serohemático.
 - Base eritematosa o normal.
 - Localización típica: abdomen inferior, ingles, axilas, cara interna de muslos, flexuras.
 - Mucosas afectadas en 10–30% (erosiones orales o conjuntivales leves).
-

3.3. Síntomas asociados

- Prurito intenso (frecuente y a veces el síntoma inicial).

- Dolor leve en lesiones rotas.
 - Ausencia de fiebre o síntomas sistémicos en la mayoría.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Pénfigo vulgar	Ampollas flácidas, signo de Nikolsky positivo, mucosas severamente afectadas
Dermatitis herpetiforme	Ampollas pequeñas agrupadas, pruriginosas, predominio en codos y nalgas
Epidermólisis ampollar adquirida	Cicatrices y milium tras resolución, inmunofluorescencia similar pero patrón distinto
Reacción medicamentosa bullosa (SSJ/NET)	Fiebre, necrosis epidérmica, compromiso mucoso extenso
Impétigo ampollar	En niños, cultivo positivo a <i>S. aureus</i>

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

- Paciente anciano con ampollas tensas pruriginosas sobre piel normal o eritematosa.
 - Signo de Nikolsky negativo.
 - Prurito intenso.
-

4.2. Exámenes complementarios

Examen	Descripción / utilidad
Biopsia de piel (lesión reciente)	Hendidura subepidérmica con infiltrado eosinofílico dérmico.
Inmunofluorescencia directa (IFD)	Patrón lineal de IgG y C3 en la membrana basal → diagnóstico confirmatorio.
Inmunofluorescencia indirecta (IFI)	Detecta anticuerpos circulantes anti-BMZ (usando piel humana o de mono).
ELISA anti-BP180 / BP230	Cuantifica anticuerpos, útil para diagnóstico y seguimiento.
Hemograma / perfil hepático y renal	Para monitorizar toxicidad de tratamiento.

4.3. Criterios diagnósticos propuestos (EAAD, 2023)

1. Ampollas tensas sobre piel eritematosa o normal.
2. Edad >60 años.
3. Biopsia con hendidura subepidérmica + infiltrado eosinofílico.
4. Inmunofluorescencia directa con IgG/C3 lineal en membrana basal.
5. ELISA positivo anti-BP180 o anti-BP230.

Diagnóstico confirmado: presencia de ≥ 3 criterios.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Objetivos terapéuticos

- Controlar el prurito y la inflamación.
 - Prevenir formación de nuevas ampollas.
 - Evitar infecciones secundarias.
 - Mantener remisión prolongada con dosis mínimas efectivas.
-

5.2. Tratamiento escalonado

A. Penfigoide leve o localizado

1. **Corticoides tópicos potentes o ultrapotentes:**
 - Clobetasol propionato 0,05% aplicado 1–2 veces/día sobre lesiones y piel perilesional.
 - Puede controlarse solo con tratamiento tópico.
 - Se recomienda aplicación extensa en ancianos institucionalizados (según MINSAL).
 2. **Antihistamínicos orales (loratadina, cetirizina):** alivio del prurito.
 3. **Antisépticos suaves y emolientes:** para prevenir infección y mantener integridad cutánea.
-

B. Penfigoide moderado a severo

1. **Corticoides sistémicos:**
 - Prednisona 0,5–1 mg/kg/día, luego reducción progresiva según respuesta (4–8 semanas).
 - Casos graves: pulsos de metilprednisolona IV (1 g/día × 3 días).
2. **Inmunomoduladores ahorradores de corticoides:**
(utilizados para mantenimiento o resistencia)

- **Azatioprina 1–2 mg/kg/día.**
- **Metotrexato 7,5–15 mg/semana.**
- **Micofenolato mofetilo 1–2 g/día.**
- **Dapsona** (si hay contraindicación a inmunosupresores).

3. Terapias biológicas (casos refractarios):

- **Rituximab (anti-CD20).**
- **Omalizumab (anti-IgE)** en PA con eosinofilia significativa.
- Se reservan para uso especializado en dermatología hospitalaria.

C. Manejo de soporte

- Higiene y cuidado de piel erosiva (compresas con sulfato de cobre o clorhexidina diluida).
- Tratar infecciones secundarias (antibióticos tópicos o sistémicos).
- Control glucémico y óseo si uso prolongado de corticoides.
- Vacunación antineumocócica e influenza en ancianos bajo inmunosupresión.

5.3. Enfoque terapéutico MINSAL (2023)

Gravedad	Tratamiento de elección	Seguimiento
Leve (<10% SC)	Corticoide tópico potente	Control mensual
Moderado (10–30% SC)	Prednisona 0,5 mg/kg/día + azatioprina	Control clínico y de laboratorio

Severo (>30% SC o mucosas)	Corticoides sistémicos + inmunomoduladores	Evaluación dermatológica especializada
----------------------------	--	--

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa / Descripción	Prevención / Manejo
Infecciones secundarias	Ruptura de ampollas, inmunosupresión	Higiene, antibióticos tópicos
Efectos adversos por corticoides	Hiperglicemia, osteoporosis, HTA	Dosis mínima efectiva, calcio/vitamina D
Deshidratación / desequilibrio electrolítico	Pérdida transcutánea en casos extensos	Hidratación adecuada
Mortalidad	Rara, <10%, más por edad y comorbilidades	Manejo integral y prevención infecciosa

Pronóstico:

- La mayoría responde favorablemente en 6–12 meses.
- Remisión completa en 70–80% de casos tratados.
- Recidiva en 20–30% tras suspensión terapéutica.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Ampollas tensas, pruriginosas, Nikolsky negativo** → **Penfigoide ampollar**.
 2. La **biopsia + inmunofluorescencia directa (IgG y C3 lineal en membrana basal)** es diagnóstica.
 3. **Corticoides tópicos potentes** pueden ser suficientes en casos leves.
 4. En ancianos institucionalizados, preferir **tratamiento tópico extensivo** para evitar efectos sistémicos.
 5. **Evitar confundir con pénfigo vulgar**, cuyas ampollas son flácidas y mucosas afectadas.
 6. En EUNACOM, clave: **paciente anciano, ampollas tensas, prurito, Nikolsky negativo**.
-



Errores comunes

- Confundir con dermatitis o urticaria crónica (fase inicial pruriginosa).
 - No realizar biopsia ni inmunofluorescencia, lo que retrasa diagnóstico.
 - Uso prolongado de corticoides sistémicos sin inmunomoduladores (efectos adversos graves).
 - Omitir profilaxis ósea o control glucémico durante terapia prolongada.
 - No derivar casos refractarios a dermatología.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **penfigoide ampollar** es la **enfermedad ampollar autoinmune más frecuente**, mediada por **anticuerpos anti-BP180 y BP230**.
2. Se caracteriza por **ampollas tensas, serosas o hemáticas, sobre piel eritematosa o normal**, con **signo de Nikolsky negativo**.

3. El **diagnóstico** se confirma con **biopsia e inmunofluorescencia directa lineal de IgG/C3** en la membrana basal.
4. El **tratamiento de primera línea** son **corticoides tópicos potentes** en casos leves y **sistémicos** en casos extensos.
5. **Azatioprina, metotrexato o micofenolato** son opciones ahorradoras de corticoides.
6. Tiene **buen pronóstico** si se trata precozmente, con remisión en la mayoría de los casos.
7. En EUNACOM, la pregunta clave describe un **paciente anciano con ampollas tensas y prurito intenso**, sin compromiso mucoso.